Cuerpos extraños y perforaciones de la faringe

O Malard
C Beauvillain de Montreuil

Resumen. – Los cuerpos extraños y las heridas de la faringe constituyen una urgencia medicoquirúrgica. Su gravedad es muy variable, pero sus posibles complicaciones, infecciosas o neurológicas, requieren un tratamiento riguroso. El examen clínico siempre debe determinar la extensión de las lesiones, buscando sistemáticamente signos de gravedad que el médico debe conocer. El examen endoscópico con anestesia general está justificado cuando el examen clínico simple es insuficiente. El tratamiento depende de la localización y de la extensión de las lesiones descubiertas, pero cualquier cuerpo extraño faríngeo debe ser retirado.

© 2000, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Introducción

Los cuerpos extraños y las perforaciones de la faringe están estrechamente vinculados, pues un cuerpo extraño faríngeo debe hacer sospechar una herida asociada hasta que se pruebe lo contrario, ya que es sobre todo esta última la que determina la conducta que se debe seguir y el pronóstico. De la naturaleza del cuerpo extraño faríngeo (consistencia, forma, asperezas, bordes afilados, cortantes o puntiagudos) dependen directamente las perforaciones, que pueden aparecer cuando se bloquea el objeto o al extraerlo. Esta patología es frecuente y su gravedad reviste grados muy variables; el cuerpo extraño faríngeo puede ser un incidente totalmente anodino o, por el contrario, provocar complicaciones graves, a veces fatales. El tratamiento de los pacientes en los que se sospecha un cuerpo extraño es una urgencia medicoquirúrgica y depende de la localización (naso, oro o hipofaríngea), de la naturaleza y de los datos clínicos que deben determinar la extensión de las lesiones. En los casos en los que el médico no puede establecer un análisis de las lesiones mediante un examen clínico simple, está justificado el examen endóscopico con anestesia general, sin olvidar que un examen radiológico normal no cuestiona el diagnóstico.

Datos epidemiológicos

Puede ocurrir a cualquier edad, pero se ha apreciado una frecuencia máxima hacia los 4 años y después de los 70 años [8]. Las circunstancias de aparición suelen ser evidentes, pero pueden pasar desapercibidas en el niño pequeño (por ejemplo, durante el juego en un parque), en el anciano o en un terreno debilitado.

Aparte de las localizaciones orofaríngeas en las que existe un predominio masculino del 64 % [12], los diferentes estudios no muestran un predominio por sexo.

Olivier Malard : *Interne des hôpitaux de Nantes.*
Claude Beauvillain de Montreuil : *Professeur des Universités, praticien hospitalier.*
Service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervicofaciale (Pr C Beauvillain de Montreuil, Pr F Legent), Hôtel-Dieu, place A Ricordeau, BP 1005, 44093 Nantes cedex 01.

Clínica

LOCALIZACIONES RINOFARÍNGEAS

Las perforaciones son poco frecuentes en esta localización porque la mucosa está protegida por los límites óseos y cartilaginosos de las cavidades nasales. Las lesiones por traumatismos externos (traumatismo balístico, proyectiles diversos) son excepcionalmente aisladas en la rinofaringe y se incluyen en los traumatismos craneofaciales con deterioro importante. Las heridas yatrógenas suelen deberse a una sonda de intubación o a una sonda nasogástrica que penetran a partir de una efracción en la pared posterior del cavum en el espacio retrofaríngeo (trayecto submucoso). Se acompañan a veces de epistaxis transitoria y tienen buen pronóstico por su tendencia a cicatrizar bien; su sobreinfección es rara.

Los cuerpos extraños son más frecuentes y de naturaleza muy diversa. Se puede tratar de fragmentos alimentarios (grano, pequeños huesos), piezas de un juguete o un trozo de tela, etc. Estos cuerpos extraños alimentarios a veces se localizan en la rinofaringe a continuación de vómitos, incluso si no existe insuficiencia velar.

Circunstancias de aparición

Conciernen esencialmente al niño. Los familiares pueden ser testigos de la penetración del cuerpo extraño en las fosas nasales; el diagnóstico es en ese caso evidente.

Síntomas

Los signos precoces asocian epistaxis, obstrucción nasal y molestia en las fosas nasales. Si el cuerpo extraño pasa desapercibido, una rinorrea unilateral purulenta y fétida aparece unos días después. Evoluciona de modo crónico, a veces transitoriamente aliviada por un tratamiento antibiótico.

El examen clínico incluye una rinoscopia anterior completada con una nasofibroscopia después de anestesia local.

Exámenes complementarios

Esta sintomatología basta para confirmar el diagnóstico y los exámenes radiográficos raramente son indispensables en estas localizaciones.

Complicaciones

Si no se diagnostica el cuerpo extraño o se deja in situ, pueden aparecer complicaciones infecciosas locales y generales (broncopulmonares), que requieren su extracción. Epistaxis, raramente severas, aparecen a veces a distancia por ulceración mucosa y son eventualmente reveladoras del cuerpo extraño. Por otra parte, se depositan concreciones calcáreas y que agrandan el cuerpo extraño y hacen que su extracción resulta más compleja, son los rinolitos.

LOCALIZACIONES OROFARÍNGEAS

Como en la rinofaringe, los cuerpos extraños y las heridas orofaríngeas a veces se deben a traumatismos externos (heridas por armas, proyectiles, etc.), y se tratan con los traumatismos craneofaciales. Según Kosaki et al [9] y Radkwoski et al [12] existe un predominio en el niño de 4 años. Las principales localizaciones son el paladar blando, los pilares del velo y la región amigdalina, la pared faríngea posterior, la base de la lengua y el surco glosoepiglótico. Las lesiones están lateralizadas en el 69 % de los casos, según un estudio de Radkowski et al [9] con 77 casos. Estas localizaciones son potencialmente peligrosas y necesitan un examen minucioso.

Circunstancias de aparición

Los cuerpos extraños son esencialmente alimentos que se fijan a la orofaringe durante la deglución. La espina de pescado es la más frecuente en aproximadamente el 40 % de los casos [8, 9]. Las heridas suelen ser ocasionadas por objetos que penetran en la mucosa orofaríngea durante caídas en niños corriendo con un objeto en forma de lápiz en la boca *(pencil injuries* de los anglosajones). Los agentes principalmente observados tienen forma de bastoncillo [9, 12]: bastoncillo de madera o de plástico, mango de cepillo de dientes, lápiz, manillar de bicicleta.

Síntomas

En caso de herida suele existir una hemorragia inicial. Seguidamente, predomina el dolor, de tipo molestia, agravándose con la deglución. No son raros dolores irradiados de tipo otalgias, sobre todo en las lesiones lateralizadas. Pueden observarse disfagia e hipersialorrea.

El examen físico permite inspeccionar minuciosamente la cavidad orofaríngea. Puede verse el cuerpo extraño (espina de pescado, por ejemplo) hundido más o menos profundamente en los tejidos blandos. Si no se visualiza el cuerpo extraño, el examen se completa con un tacto digital suave de la base de la lengua, con una laringoscopia indirecta o una nasofibroscopia con anestesia local. Si sigue sin evidenciarse, puede ser útil volver a citar al paciente 48 horas después, para evaluar la persistencia de los síntomas y efectuar un nuevo examen clínico. Según Jones et al [8], el cuerpo extraño orofaríngeo sólo se encuentra en el 59 al 68 % de los casos según la localización. En caso de herida, es necesario determinar la localización, los límites, la profundidad y la existencia de contusión, necrosis o restos telúricos. En el niño, se puede recurrir al examen con anestesia general.

El examen general verifica el estado hemodinámico. Si el accidente es antiguo, el examen cervical y general se cerciora de la ausencia de signos infecciosos locales. Por último, el examen de cualquier herida orofaríngea, principalmente si es lateralizada y profunda, conlleva un examen neurológico estándar: estudio de la motricidad, del reflexograma, del campo visual, de la capacidad de concentración y del comportamiento.

Exámenes complementarios

Salvo en los cuerpos extraños limitados, fácilmente curables, es necesaria una radiografía cervical para investigar sistemáticamente [15] además de un cuerpo extraño radioopaco signos de complicación de tipo enfisema retrofaríngeo. En estos casos, siempre se solicita una radiografía de toráx en busca de un neumomediastino que puede complicar un enfisema retrofaríngeo por la presión negativa intratorácica.

Complicaciones

Las complicaciones constituyen la evolución de los cuerpos extraños y heridas faríngeas temida por el médico.

Según Singh et al [13] acerca de 327 cuerpos extraños de las vías aéreas digestivas superiores, las complicaciones afectan al 7,6 % de los pacientes. El riesgo aumenta con la edad (4,8 % antes de los 10 años frente al 12,6 % después de los 10 años). Además, un retraso en el tratamiento de 24 horas y un cuerpo extraño afilado o puntiagudo aumentan significativamente el riesgo de complicaciones. Las complicaciones infecciosas son la abscedación para o retrofaríngea [13, 15], la más frecuente, que pone en peligro el pronóstico vital; las celulitis cervicofaciales, como la excepcional fascitis necrotizante [18], la mediastinitis [15, 17] y las bronconeumopatías [12]. Las complicaciones neurológicas [7] son raras, pero constituyen una entidad clínica inicialmente descrita por Cadwel [1] en 1936. Deben sospecharse en caso de lesiones profundas de la región lateral del paladar blando o de la región periamigdalina. El mecanismo en cuestión es un desgarro de la íntima de la carótida interna por aplastamiento de la arteria entre el cuerpo extraño y las apófisis transversales de la segunda y tercera vértebras cervicales. Aparece entonces una trombosis vascular después de un intervalo libre, incluso en ausencia de herida arterial [11]. El intervalo libre varía de 4 a 48 horas; luego puede aparecer una hemiplejía contralateral a la lesión, una hemianopsia lateral homónima y una afasia si el hemisferio dominante se ve afectado. Precediendo a los signos de localización neurológica, deben llamar la atención los vómitos, la irritabilidad o una somnolencia anómala. La sospecha de isquemia en el territorio silviano requiere hospitalización en medio especializado para poder realizar un diagnóstico por imágenes cerebrales mediante TC y una arteriografía carotídea.

LOCALIZACIONES HIPOFARÍNGEAS

Son raramente resultado de traumatismos externos (heridas cervicales cualquiera que sea la causa) y sobre todo se deben a una penetración endobucal a raíz de un movimiento de deglución. El grado de recidiva es inferior al 1 %. En el 5,5 % de los casos, se observa un antecedente de trastorno de la deglución (accidente vascular cerebral, estenosis péptica, divertículo faríngeo, neuropatía diabética periférica) [8]. Para los traumatismos externos, Stanley et al [16] han mostrado que su gravedad es mayor cuando la herida es baja, situada hacia el esófago cervical, principalmente por debajo del borde superior de los cartílagos aritenoides, lo que se ha propuesto como límite que permite tratamiento médico.

Circunstancias de aparición

Suelen ser evidentes, salvo en el niño muy pequeño. Su mecanismo de aparición es similar al de los cuerpos extraños y heridas del esófago cervical.

Los cuerpos extraños alimentarios son los más frecuentes, pero todos son posibles (prótesis dentarias, imperdibles, monedas, juguetes, etc.). Las localizaciones preferentes son la región retrocricoidea, encima de la boca esofágica, el borde superior de los senos piriformes, la pared hipofaríngea posterior.

Síntomas

En el caso del cuerpo extraño alimentario, el primer signo funcional es el dolor, que va de la simple disfagia al dolor violento durante la deglución del bolo alimenticio, a veces

seguido de una hipersialorrea. Seguidamente la intensidad del dolor puede disminuir y la deglución puede volver a desencadenarlo (odinodisfagia). La irradiación auricular también es posible. Una hemorragia exteriorizada por la boca es rara. Por último, la disfonía es rara y la disnea inspiratoria excepcional.

En el examen se buscan signos de complicación local: enfisema subcutáneo a la palpación cervical, tortícolis. En el examen físico, completado con una laringoscopia indirecta o una nasofibroscopia con anestesia local, se busca un cuerpo extraño dentro de una estasis salival.

Exámenes complementarios

Salvo en los cuerpos extraños limitados, fácilmente curables, se debe llevar a cabo una radiografía cervical torácica: lo visualiza si es radioopaco y analiza la región prevertebral en busca de una colección aérea (signo de Minnigerode) que indica una perforación faríngea parietal e impone una intervención urgente.

Un examen radiográfico normal no debe ser erróneamente tranquilizador; el interrogatorio y los signos clínicos prevalecen. Según Marais et al [10] acerca de 60 cuerpos extraños faríngeos, sólo el 38,3 % de los retirados por endoscopia eran visibles radiológicamente, mientras que el 26,3 % eran falsos positivos. El análisis radiográfico es complicado por las calcificaciones laríngeas fisiológicas.

Complicaciones

Como en la localización orofaríngea, la edad, el retraso en el tratamiento y la naturaleza afilada o cortante del cuerpo extraño, aumentan el riesgo de complicaciones.

Las complicaciones son sobre todo infecciosas: abscesos y celulitis cervical, a veces asociados a una fístula salival, mediastinitis, cuya mortalidad es del 50 %, según Dolgin et al [3]. Se han descrito otras complicaciones más raras [4, 14]: migración mediastínica o cervical del que necesita una exéresis quirúrgica.

Tratamiento

LOCALIZACIONES RINOFARÍNGEAS

Una vez establecido el diagnóstico de cuerpo extraño rinofaríngeo, se impone su exéresis para prevenir las complicaciones. Idealmente es retirado con anestesia local en medio especializado, evitando las pinzas que desplazan los cuerpos extraños hacia el cavum. Se prefiere una pinza curva o un escobillón introducido por detrás del cuerpo extraño, que se extirpa sin traumatismo. En caso de necesidad (mala cooperación del niño, cuerpo mal visualizado), se impone una extracción con anestesia general, ayudándose de instrumentos ópticos endonasales.

LOCALIZACIONES OROFARÍNGEAS

Los cuerpos extraños simples y bien visibles son retirados con la pinza bajo anestesia local. En caso de localización menos accesible (valéculas), la extracción se realiza con anestesia local y una pinza de biopsia laríngea o con anestesia general y tubo rígido. La utilización de un nasofaringoscopio equipado de una pinza de prensión con anestesia local es una buena alternativa a la anestesia general siempre y cuando el cuerpo extraño sea de pequeño tamaño. Es una técnica rápida, bien tolerada y con una baja morbilidad [2, 5]. Su utilización está limitada por el coste de tales fibroscopios y por la experiencia del médico. Un tratamiento antibiótico activo frente a los cocos grampositivos es prescrito a continuación durante 6 días (penicilina del grupo V o A, macrólido). Pueden asociarse enjuagues. Las heridas orofaríngeas se tratan según la extensión y la localización de las lesiones. Para una herida simple, poco profunda, un simple tratamiento antibiótico y enjuagues son suficientes.

Una herida profunda, contusa, mal limitada, aún más si está lateralizada, es explorada, desbridada, y suturada con anestesia general y un tratamiento antibiótico y enjuagues. Para Hengerer et al [6], un control en medio hospitalario es deseable durante 24 horas, habida cuenta del intervalo libre que puede preceder a la trombosis carotídea. Una actitud más adaptada a la frecuencia de estos traumatismos [12] consiste en autorizar el alta del niño explicando a los familiares la necesidad de vigilarlo y de acudir urgentemente si aparecen modificaciones del comportamiento.

LOCALIZACIONES HIPOFARÍNGEAS

Los cuerpos extraños son retirados prudentemente, muy a menudo con anestesia general e hipofaringoscopia rígida. La extracción debe evitar agravar el traumatismo. Si el tamaño del cuerpo lo permite, la utilización de un nasofaringoscopio flexible equipado con una pinza de prensión con anestesia local, es una buena alternativa. En ausencia de heridas, no se impone ningún otro tratamiento. En caso de herida evidente o de cuerpo extraño perforante, la cervicotomía exploradora permite una sutura primaria de la mucosa. Un drenaje de la región en caso de diagnóstico tardío previene el riesgo de mediastinitis. La colocación de una sonda nasogástrica y una antibioticoterapia parenteral profiláctica introducida precozmente y sin sutura parecen ser suficientes según algunos autores [3], pero esta actitud sigue siendo motivo de debate.

Por último, en caso de traumatismo externo, la localización supraaritenoidea permite un tratamiento farmacológico [16], mientras que una lesión infraaritenoidea parece ser la indicación de una reparación quirúrgica primaria.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Malard O et Beauvillain de Montreuil C. Corps étrangers et perforations du pharynx. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-620-A-10, 1998, 4 p.

[1] Cadwel JA. Post-traumatic thrombosis of internal carotid artery. *Am J Surg* 1936 ; 32 : 523-552

[2] Choy AT, Gluckman PG, Tong MC, Van Hasselt CA. Flexible nasopharyngoscopy for fish bone removal from the pharynx. *J Laryngol Otol* 1992 ; 106 : 709-711

[3] Dolgin SR, Wykoff TW, Kumar NR, Maniglia AJ. Conservative medical management of traumatic pharyngoesophageal perforations. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1992 ; 101 : 209-215

[4] Gertner R, Bar'el E, Fradis M, Podoshin L. Unusual complication of an ingested foreign body. *J Laryngol Otol* 1991 ; 105 : 146-147

[5] Goldstein SI, Weiss MH. Fiberendoscopic removal of pharyngeal foreign bodies. *Laryngoscope* 1987 ; 97 : 108-109

[6] Hengerer AS, De Groot TR, Rivers RJ. Internal carotid artery thrombosis following soft palate injuries : a case report and a review of 16 cases. *Laryngoscope* 1984 ; 94 : 1571-1575

[7] Higgins GL, Meredith JT. Internal carotid artery thrombosis following penetrating trauma of the soft palate injuries : an injury of youth. *J Fam Pract* 1991 ; 32 : 316-322

[8] Jones NS, Lannigan FJ, Salama NY. Foreign bodies in the throat : a prospective study of 388 cases. *J Laryngol Otol* 1991 ; 105 : 104-108

[9] Kosaki H, Nakamura N, Toriyama Y. Penetrating injuries to the oropharynx. *J Laryngol Otol* 1992 ; 106 : 813-816

[10] Marais J, Mitchell R, Wightman AJ. The value of radiographic assessment for oropharyngeal foreign bodies. *J Laryngol Otol* 1995 ; 109 : 452-454

[11] Pitner SE. Carotid thrombosis due to intraoral trauma : an unusual complication of a common childhood accident. *N Engl J Med* 1966 ; 274 : 764-767

[12] Radkowski D, Mc Gill TJ, Healy GB, Jones DT. Penetrating trauma of the oropharynx in children. *Laryngoscope* 1993 ; 103 : 991-994

[13] Singh B, Kantu M, Har EG, Lucente FE. Complications associated with 327 foreign bodies of the pharynx, larynx, and esophagus. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1997 ; 106 : 301-304

[14] Sinha A, Shotton JC. An unusual foreign body migrating from pharynx to mediastinum. *J Laryngol Otol* 1996 ; 110 : 279-280

[15] Smyth DA, Fenton J, Timon C, Mc Shane DP. Occult pharyngeal perforation secondary to « pencil injury ». *J Laryngol Otol* 1996 ; 110 : 901-903

[16] Stanley RJ, Armstrong WB, Fetterman BL, Shindo ML. Management of external penetrating injuries into the hypopharyngeal-cervical esophageal funnel. *J Trauma* 1997 ; 42 : 675-679

[17] Tostevin PM, Hollis LJ, Bailey CM. Pharyngeal trauma in children - accidental and otherwise. *J Laryngol Otol* 1995 ; 109 : 1168-1175

[18] Yii NW, Quinn SJ, Andersson LC, Niranjan NS, Kenyon GS. Cervical necrotising fasciitis with pharyngeal perforation : treatment and reconstruction. *Br J Plast Surg* 1996 ; 49 : 237-241